

9주차 1교시. 청소년과 자살

1. 자살에 대한 이론적 이해

1) 자살의 개념정의

- 일반적 정의 : 자살은 고의적이며 자발적으로 자신의 목숨을 끊는 것
- 사회학 사전정의 : 자신에게 해가 되는 적극적, 소극적 행위로부터 직접, 간접으로 초래되는 모든 경우의 죽음
- 세계보건기구(WHO) 정의 : 자살은 자살행위로 인하여 죽음을 초래하는 경우로, 죽음의 의도와 동기를 인식하면서 자신에게 손상을 입히는 행위로 정의
- 뒤르켐(Durkheim, 1951) 정의 : 자살을 장차 초래될 결과를 알고 자신에게 행하는 적극적 또는 소극적 행동의 직접적 또는 간접적 죽음의 형태를 띠고 있는 자신에 대한 살인행위

2) 뒤르켐(Durkheim) 자살의 유형

- 뒤르켐이 제시한 자살유형을 통하여 자살은 사회학에서 매우 큰 영향력이 있다.
- 자살률을 한 사회에서 사회통합의 수준과 사회적 규제에 따라 분류
 - 사회통합 정도에 따라 : 이기적 자살, 이타적 자살
 - 사회적 규제에 따라 : 아노미적 자살, 숙명적 자살

(1) 이기적 자살(Egoistic Suicide)

- 이기적 자살은 사회통합 정도가 낮은 사회에서 주로 발생한다.
- 사회로부터 멀어지고, 존재의 의미를 찾지 못해 방황하는 사람에게서 주로 발생한다.
- 집단 의식이 낮고 개인주의가 팽배한 사회에서도 자주 발생한다.
- 이기적 자살을 하는 사람은 정신적 문제로 고통을 받고 있거나, 최근 상실을 경험한 사람들이 대부분인 경우로, 우울증과 냉담함을 보인다.

(2) 이타적 자살(Altruistic Suicide)

- 과도한 사회통합과 집단주의로 인해 개인의 가치나 생명이 과소평가되는 사회에서 발생한다.
- 이 경우 자살은 의무적인 행위로 강요될 수 있으며, 때로는 존경할 만한 행위로 간주
 - 예 : 2차 세계 대전 당시 일왕과 일본의 승전을 위해 폭탄을 장착한 전투기에 몸을 싣고 미군 함대를 공격했던 가미카제 특공대, 중동지역 자살 폭탄테러 등

(3) 아노미적 자살(Anomic Suicide)

- 사회규범이 상실된 상태에서 나타나는 자살
- 경제나 정치위기와 같은 사회위계나 규범이 갑작스럽게 붕괴되어 개인의 일상생활의 방향성을 상실했거나, 심각한 정체성 혼란을 경험할 때 발생한다.
- 전쟁이나 혁명으로 인해 기존의 규범체제가 와해되고 극도의 혼란상황이 왔을 때 이에 대한 탈출구로 자살을 선택한다.
- 현대사회에서 자살을 사회문제로 이야기할 때는 '아노미¹⁾로 인한 자살을 의미한다.
 - 예 : 이혼이 흔한 사회에서의 자살. 이혼이라는 특정 아노미에서 파생된 '혼돈'이 특정 사회에 끼치는 극단적 영향은 그 사회의 높은 자살률로서 보여 진다.

(4) 숙명적 자살(Fatalistic Suicide)

- 자신을 둘러싸고 있는 환경을 극복할 능력이 없다고 믿을 때 발생한다.
- 사회적 통제가 지나치게 강하여 이것을 더 이상 극복할 수 없다고 생각할 때, 미래에 대한 희망을 상실했을 때 발생한다.
 - 예 : 청소년들이 주로 과도한 사회규범(학벌위주의 진학과 성공)에 따른 미래에 대한 희망을 상실하고 탈출구로서 자살을 선택

1) 아노미란 개인의 부적응과 이탈 소속감의 상실로 인해 일상생활에서 규범과 규칙이 실종되는 상태를 가리킨다.

2. 자살행동의 위험요인과 보호요인

1) 자살행동

- 자살행동(Suicidal Behavior)은 개인이 스스로 목숨을 끊기 위해 행하는 자발적 행동
- 자살사고(Suicidal Ideation), 자살계획(Suicidal Plan), 자살시도(Suicide Attempt)를 자살 행동에 포함시킬 수 있다.
- 자살사고는 자살에 대한 막연한 생각(세상살기 싫다, 산다는게 의미없다)에서부터 계획 이 수반된 구체적인 생각(약을 먹고 죽겠다)에 이르기까지 다양하다.
- 사람들은 자살행동을 사전계획 없이 우발적으로 하기도 하고, 철저한 계획을 통한 자살 을 시도하기도 한다.

[청소년이 자살을 선택하는 경우?]

- ① 자신이 직면한 문제를 이해하는 사람이 주변에 없다고 느낄 때
- ② 문제해결 방법이 막막할 때
- ③ 혹은 이러한 문제에 압도되어 깊은 절망감과 좌절감을 지속적으로 느낄 때
- ④ 자신의 문제와 유사한 문제를 가진 또래가 자살을 시도했거나 성공했다는 소식을 접 했을 때

2) 자살행동의 위험요인과 보호요인

- 위험요인 : 개인을 둘러싸고 있는 내·외적 환경이나 개인의 특성 중 부정적인 영향을 미치는 요인
- 보호요인 : 개인의 발달에 부정적인 영향을 감소시키고 개인의 위험요인을 감소시킬 수 있도록 도와주는 요인

[표 9-1. 자살의 위험요인과 보호요인]

구분	위험요인	보호요인
개인요인	- 자아에 대해 부정적, 낮은 자아존중감 - 비현실적인 높은 기대, 낮은 성취감 - 우울증, 알코올과 약물남용 - 정서적 사회적인 고립 - 친밀한 관계의 상실 및 대화 단절 - 무력감, 미래에 대한 희망이 없음 - 이성 혹은 양육자와의 문제 - 자살시도 경력, 충동성, 공격적 성향 - 반복적인 스트레스 및 대처기제의 부족 - 가족과 학교에 대한 애착과 헌신 부족	- 원만한 대인관계 및 문제해결기술 - 효과적인 스트레스 대처기술 - 도움 요청의 기술 - 긍정적인 자아존중감
가족요인	- 가족 구성원의 자살시도 경험 - 가족의 응집성 결여 - 부부간 또는 부모·자녀 간의 잦은 갈등 및 가정폭력 - 경제적 빈곤과 부모의 실직 - 부모로부터의 정서적 박탈, 의사소통 결여 - 가족구성원의 자율적 기능을 지지하지 않음	- 가족과 지역사회의 지원과 지지 - 가정폭력, 빈곤 등의 문제에 적극 개입 - 높은 가족 응집력과 원만한 의사소통 - 부모-자녀 관계가 지지적이고 친밀함 - 경제적 안정
또래/학교요인	- 학교 부적응, 학교공포, 등교거부 - 친구(이성, 동성) 문제 - 성적부담 및 학업관련 스트레스 - 빈약한 친구관계 - 학교폭력, 집단따돌림	- 또래 및 교사와의 원만한 관계 및 지지망 - 학교에서의 예방교육과 정신건강 서비스의 제공 - 멘토 및 사회지지망 구축
사회요인	- 인터넷 사이트나 매스미디어를 통한 왜곡된 죽음의 이미지나 정보 - 자살을 미화하는 문화적 및 종교적 신념 - 정신건강 치료에 대한 장애 - 낮은 사회적 지지도	- 정신건강 치료기관의 접근성 용이 - 청소년 우울 및 자살에 대한 예방교육(개인의 생명과 가치를 존중) - 자살위기센터의 설치운영 - 유해화학 물질에 대한 엄격한 관리

3. 청소년 자살 예방과 대처방안

1) 자살에 대한 개입

- 청소년 자살예방프로그램은 자살의 위험요소를 낮추고 보호요소를 증가시킴으로서 청소년들의 유연성을 길러줄 수 있는 강점지향적인 활동들로 구성
- 자살에 대한 개입 시 경청, 위험요소 파악, 적절한 전문기관으로의 의뢰가 우선
- 일반적으로 청소년들이 보이는 자살시도는 성인들에 비해 일시적이거나 충동적

2) 자살위험징후에 따른 예방

(1) 저위험에서 고위험으로 갈수록 위험

저위험	▪ 현재 자살을 생각하지 않는 경우 ▪ 과거에 자살행동을 하지 않은 경우 ▪ 만성적인 어려움(질병, 가난 등)이나 상실에 대한 걱정이 없는 경우 ▪ 자살행동을 안하게 만드는 이유가 있는 경우(ex: 가족, 친구 등)
중위험	▪ 자살사고나 자살행동에 대한 열망 ▪ 오랫동안 약물이나 알코올 사용 ▪ 관계상의 문제나 말썽, 기타 스트레스에 의해 위험요소가 가중되는 경우
고위험	▪ 과거 수차례의 자살시도 ▪ 현재 자살사고와 계획이 있는 경우 ▪ 예기되는 촉발사건이 존재

(2) 만성위험 & 급성위험

만성위험	▪ 이전의 자살행동과 현재의 위험요소(특히 알코올, 약물남용, 인격장애)가 존재하여 자살행동을 하려고 하며, 현재 자살의도나 자살계획을 갖고 있는 경우는 만성질환에 해당 ▪ 만성위험에 속한 사람들은 긴박한 위험이 포함되지는 않으나, 특정한 상황(우울증의 재발, 실제의 혹은 예기되는 관계상실, 재정악화, 법적문제, 심각한 내과질환의 진단 등)에 처하게 되면 급속하게 자살위험이 높아질 수 있다.
급성위험	▪ 최근 심각한 자살행동, 정신질환의 진행이나 심각한 자살계획/의도를 가지고 있는 경우로, 급성위험에 속한 사람들은 수 시간, 수일 혹은 수주 이내로 자살시도의 가능성이 있다고 봄 ▪ 매우 높은 자살의 위험을 갖고 있는 대상자들의 문제를 신속히 규명하여 즉각적인 중재를 제공하는 것이 중요

(3) 개입이 필요한 자살 징후들

- 평소 잘 하지 않던 주변 정리를 할 때
- 평소 아끼던 물건을 주변 사람에게 주며 잘 간직하라고 할 때
- 성적이 급격히 하락할 때
- 식습관, 수면 습관에 변화가 생길 때
- 짜증, 분노가 많아질 때
- 약이나 칼 등을 찾을 때
- 죽음에 대한 이야기들을 많이 할 때
- 죽음에 대해 긍정적으로 말하거나 이상적으로 표현할 때
- 무모하고 위험한 일에 가담해서 사고를 발생시킬 때

3) 단계별 자살예방 대책

(1) 1차 예방

활동분야	내용
학교교육	▪ 지속적인 자살예방 교육 및 스트레스 대처, 정신건강증진 교육 필요 ▪ 학교현장의 자살위기 관리능력을 키울 수 있도록 교육행정가의 적극적 관심과 지원이 필요 ▪ 학교기반 자살예방 프로그램은 모든 학생들 대상 - 교육을 통해 자살행동을 할 가능성이 있는 사례들을 사전에 발견하고, 위험에 처한 학생들이 도움을 청할 수 있도록 권장 ▪ 최근 학교현장에서는 자살행동에 초점을 두기 보다는 대처기술 강화, 자긍심 강화, 문제해결과 대화기술에 초점을 둔 일반적 프로그램을 권장
상담 및 사회복지	▪ 청소년의 전반적 삶의 질을 향상시키고 위기대응능력을 강화시킬 수 있도록 사회적 관심과 노력이 필요 ▪ 자살충동을 느낄 때 전화상담이나 사이버상담을 할 수 있도록 ‘헬프콜 청소년전화 1388’을 운영 ▪ 취약한 청소년의 스트레스 대처능력을 지지해줄 수 있는 포레지원시스템 등과 같은 지원체계 마련
보건의료 언론교육	▪ 우울증, 주의력결핍과잉행동장애(ADHD), 품행장애, 알콜남용 등 우울감과 충동성으로 자살위험을 높일 가능성이 있는 정신건강 문제에 대한 조기발견과 양질의 치료 제공 ▪ 대중매체도 자살을 다룰 때 이를 미화시키거나 과잉 보도하는 것을 경계하고, 책임 있고 정확한 보고를 할 수 있는 민감함이 요구

(2) 2차 예방

활동분야	내용
공통	▪ 학교와 청소년 상담기관, 정신보건서비스기관 등에서는 자살위기 고위험군을 효율적으로 선별, 의뢰하기 위한 통일된 평가도구(Tool) 개발 ▪ ‘자살 등 위기상담을 위한 전국공통전화(1577-0199)’와 위기 대응시스템 등이 지역 내 전문 지원인력과 효율적으로 연계될 수 있도록 원스톱 체제 마련 ▪ 자살 위험이 높은 청소년의 응급보호체계 마련
학교교육	▪ 자살위험군 학생 발견 시 자살위험도 평가를 의무화하고, 자살위험도 수준에 따른 대응지침을 개발, 공유 ▪ 저위험군에 대해선 부모에게 반드시 알리는 한편 학교 내외에서 학생을 보호할 수 있는 안전망을 확보하고, 수시로 학생 상태를 점검해야 한다. ▪ 중간위험군에 대해선 학생 안전을 우선적으로 확보하고, 학교 내 상담프로그램 제공 및 강화, 필요에 따라 정신건강의학과에 의뢰하는 한편, 학부모에게 알리고 자문하며, 교사 대상으로는 학급 내 학생안전에 대한 정보 가이드라인 등이 제공되어야 한다. ▪ 고위험군에 대해선 반드시 정신건강의학과 및 정신보건서비스로 의뢰를 의무화해야 한다.
상담 및 사회복지	▪ 24시간 응급체계와 연계된 상담체계 강화, 상담 및 사회복지 인력을 대상으로 청소년 자살개입 역량 강화 ▪ ‘청소년통합지원체계(Community Youth Safety-Net, CYS-net)’ 내 청소년 자살문제를 통합적이고 효율적으로 운영할 수 있도록 예산 지원
보건의료	▪ 지역 내 응급의료시스템과 정신보건서비스가 효율적으로 연계되는 자살 위기대응 시스템 구축 ▪ 취약계층에 속한 자살위험군 청소년에 대한 의료보험제도나 의료비 지원 시스템 마련

(3) 3차 예방

- 자살시도가 이루어진 경우, 개인별 및 위험집단의 위기에 신속한 개입, 행정가 및 교사, 학부모 대상의 정보 및 자문 제공, 정신건강 관련 활용할 수 있는 자원에 대한 홍보, 유가족 지원 및 상담 등과 같은 활동 등이 통합적이고 적극적으로 제공되어야 한다.
- 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있다.

4) 청소년 자살 예방

(1) 개인적 차원의 예방대책

- 첫째, 자신의 감정을 충분히 표현할 수 있도록 한다. 자신의 감정을 다양한 언어로 표현해 보는 훈련을 하고, 부정적인 감정이나 슬픈 감정이 떠오르는 것에 대하여 회피하거나 부인하지 않고 있는 그대로 받아들이는 연습이 필요하다.
- 둘째, 우울하거나 부정적인 감정을 전환할 수 있는 탈출구를 마련한다. 자신만의 스트레스 해소 방법을 찾아 우울하거나 부정적인 감정이 찾아올 때, 탈출구로 나아가는 연습을 한다.
- 셋째, 자신의 생각을 정리한다. 갈등상황을 빨리 벗어나거나 회피하고자 양자택일의 사고방식을 하고 있지는 않은지 자신을 객관적으로 바라보는 것이 필요하다.
- 넷째, 상황에 대한 해결방안을 찾도록 도움을 요청한다. 청소년은 자신의 상황을 확대 해석하여 부정적 감정에 빠질 위험이 큰 만큼, 자신의 이야기를 들어줄 수 있는 친구, 가족, 상담기관 등을 통해 도움을 받도록 용기를 내야 한다.

(2) 가정에서의 예방대책

- 첫째, 가정은 청소년의 신체적·심리적·정신적 성장의 기초가 되는 공간으로서, 안정적인 가정에서 청소년의 건강한 발달이 이루어질 수 있도록 환경을 조성한다.
- 둘째, 부모는 자녀에게 과잉 기대를 하기보다 올바른 인성을 갖출 수 있도록 긍정적인 지지와 안정적인 지원을 해주어야 한다.
- 셋째, 올바른 양육 태도와 일관성 있는 훈육으로 자녀가 규범을 지키고 자신의 감정을 절제하며 적절히 표현할 수 있도록 부모의 책임 있는 역할이 필요하다.
- 넷째, 자녀가 지닌 고민을 자연스럽게 이야기하고 해결방법을 모색할 수 있도록 평소 자녀와의 눈높이를 맞춘 대화를 하기 위해 노력해야 한다.

(3) 학교에서의 예방대책

- 첫째, 지나친 성적 위주의 교육에서 벗어나 개인의 개성을 자유롭게 표현할 수 있는 다양한 교육 프로그램이 진행되어야 한다.
- 둘째, 주입식 교육으로 인한 사고의 획일성을 지양하고, 다양한 창의력이 발휘될 수 있는 수업으로 변해야 한다.
- 셋째, 존경과 존중을 바탕으로 교사와 학생 간의 신뢰가 형성되도록 학교문화를 조성한다.
- 넷째, 다양한 신체활동을 통해 학습의 능률이 향상되는 학교현장이 되어야 한다.
- 다섯째, 학교에서 원활한 또래 관계가 형성될 수 있도록 학교폭력 예방교육을 적극적으로 실시한다.
- 여섯째, 학교생활에 어려움을 호소하는 학생들의 고민을 들어주고 문제를 해결할 수 있는 Wee클래스 활성화를 위해 학교와 관계기관의 체계적인 지원이 필요하다.

(4) 지역사회·정부차원의 예방대책

- 학교폭력의 피해로 대인관계의 어려움을 호소했거나, 학업성적의 급격한 하락으로 불안 증세를 보였거나, 평소와 다른 행동으로 심리적 변화가 나타난 경우, 특별한 관심을 갖고 학교 상담센터나 지역사회 청소년 전문상담기관(시·도 청소년상담복지센터, 정신건강증진센터 등)에 연락하여 신속한 대처를 취해야 한다.
- 경미한 우울증이나 스트레스 증상을 보이는 청소년이라 할지라도 주기적인 상담과 세심한 관리를 지속적으로 진행하고, 특히 고위험군의 우울증상이나 자살생각을 하는 청소년에게는 자살에 대해 직접적으로 물음으로써 자살생각을 노출시키고 적극적으로 개입한다.
- 정부 차원에서 중앙자살예방센터의 자살에 관한 통계, 보건복지부의 자살예방정책사업 지원, 자살예방 홍보, 유해정보와 미디어 모니터링 등의 사업을 지속적으로 확대·실시해 나가야 한다.
- 청소년 자살예방을 위한 체계적이고 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 건강가정지원센터, 지역교육청, 청소년상담지원센터, 지역사회 청소년 관련 단체·시설 등의 긴밀한 협조체계를 구축하여 적극적인 예방을 위한 실천적 교육과 함께 자살위험과 관련한 지역사회 환경개선에 앞장서야 한다.

■ 학습정리

1. 자살에 대한 이론적 이해

- 세계보건기구(WHO) 정의 : 자살은 치명적인 결과를 초래하는 자해행위이며, 자해행위란 어느 정도 자살의도를 갖고 그 동기를 인지하면서 자기 자신에게 가한 상해
- 뒤르켐(Durkheim, 1951) 정의 : 자살을 장차 초래될 결과를 알고 자신에게 행하는 적극적 또는 소극적 행동의 직접적 또는 간접적 죽음의 형태를 띠고 있는 자신에 대한 살인행위
- 뒤르켐(Durkheim)은 자살의 유형을 사회통합 정도에 따라 ‘이기적 자살’과 ‘이타적 자살’로, 사회적 규제에 따라 ‘아노미적 자살’과 ‘숙명적 자살’로 분류

2. 자살행동의 위험요인과 보호요인

- 자살행동은 개인이 스스로 목숨을 끊기 위해 행하는 자발적 행동
- 위험요인 : 개인을 둘러싸고 있는 내·외적 환경이나 개인의 특성 중 부정적인 영향을 미치는 요인
- 보호요인 : 개인의 발달에 부정적인 영향을 감소시키고 개인의 위험요인을 감소시킬 수 있도록 도와주는 요인

3. 청소년 자살 예방과 대처방안

- 청소년 자살 예방프로그램은 자살의 위험요소를 낮추고 보호요소를 증가시킴으로서 청소년들의 유연성을 길러줄 수 있는 강점지향적인 활동들로 구성
- 개입이 필요한 자살 징후들
 - 평소 잘 하지 않던 주변 정리, 평소 아끼던 물건을 주변 사람에게 주며 잘 간직하라고 할 때, 성적이 급격히 하락할 때, 식습관·수면 습관에 변화가 생길 때, 짜증·분노가 많아질 때, 약이나 칼 등을 찾을 때, 죽음에 대한 이야기들을 많이 할 때, 죽음에 대해 긍정적으로 말하거나 이상적으로 표현할 때, 무모하고 위험한 일에 가담해서 사고를 발생시킬 때 등
- 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있다